LOGBOOK KEGIATAN HARIAN ASUHAN KEPERAWATAN HEMODIALISIS

UNIT PELAYANAN HEMODIALISIS (DIALYSIS CENTER) - RS HAPPY LAND MEDICAL CENTRE

Nama Perawat : Ns. ....., S.Kep

NIP / NIRA : .....

Ruangan / Unit : Unit Hemodialisis

NO	KATEGORI FASE ASUHAN	URAIAN KEGIATAN SPESIFIK PERAWAT HEMODIALISIS	STANDAR SPO / INDIKATOR MUTU	TANGGAL PELAKSANAAN (BULAN B																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BAGIAN I: KESIAPAN FASILITAS RUANGAN HEMODIALISIS & SISTEM WATER TREATMENT (RO)																					
1.1	**Kesiapan RO & Water Treatment**	Memastikan Filter RO, ketersedian Air Baku, Air Distribusi, dan Pompa Air Tersedia dan Layak	Cek Harian pre, intra dan Post pelayanan																		
1.2	**Kesiapan Ruangan & Lingkungan**	Memeriksa kelayakan suhu, kelembaban ruangan HD, ventilasi udara, dan kebersihan lingkungan bed pasien.	Suhu 20 - 24°C, ruang reguler & isolasi (HBsAg/HCV/HIV) terpisah bersih																		
1.3	**Kesiapan Ruangan & Darurat**	Memeriksa kesiapan peralatan emergency: Emergency Trolley (segel utuh/obat komplit), Defibrillator/AED, Suction, dan Oksigen sentral.	Cek harian checklist emergency, siap pakai sewaktu-waktu																		
BAGIAN II: PERSIAPAN PERAWAT, PERALATAN, MESIN HD & ALAT KESEHATAN (PRE-HD)																					
2.1	**Persiapan Perawat (PPI)**	Menerapkan kebersihan tangan 6 langkah WHO dan penggunaan APD level HD lengkap (apron/gaun, masker bedah, faceshield/google, sarung tangan).	Kepatuhan Hand Hygiene & APD 100% sebelum kontak alat/pasien																		
2.2	**Persiapan Mesin Dialisis**	Menghidupkan mesin HD, memverifikasi kelulusan Self-Test mesin (alarm detector, venous clamp, pressure transducer, blood pump test).	Hasil Self-Test Mesin 'PASSED', tidak ada error/alarm gagal kalibrasi																		
2.3	**Persiapan Konsentrat Dialisat**	Memasang konsentrat dialisat (Part A Acid & Part B Bikarbonat) dan menghubungkan selang suplai air RO ke mesin HD.	Sesuai resep dokter, verifikasi expired date & kejernihan cairan																		
2.4	**Persiapan Dialyzer & Bloodlines**	Memeriksa kesesuaian dialyzer (baru / re-use). Jika re-use: verifikasi kesesuaian nama pasien, nomor re-use, tanggal proses, dan TCV/priming volume > 80%.	Identitas re-use tepat 100%, TCV >= 80%, uji residu sterilan negatif (0 ppm)																		
2.5	**Priming & Rinsing Sirkuit**	Melakukan priming dan pembilasan sirkuit darah (AVBL & Dialyzer) menggunakan NaCl 0.9% secara aseptik hingga bebas udara dan partikel.	Minimal 500 mL NaCl 0.9%, bebas bubble udara, heparinized jika diinstruksikan																		
2.6	**Verifikasi Uji Kimia & Fisik Mesin**	Memastikan suhu dialisat (36.0 - 37.0°C) dan konduktivitas dialisat mesin berada pada rentang aman sebelum disambung ke pasien.	Konduktivitas 13.5 - 14.5 mS/cm, temperatur stabil, lampu indikator hijau																		
BAGIAN III: IDENTIFIKASI PASIEN, PENGKAJIAN PRE-HD & KESELAMATAN PASIEN (PATIENT SAFETY)																					
3.1	**Identifikasi Pasien (SKP 1)**	Melakukan identifikasi aktif pasien secara verbal dan mencocokkan dengan gelang identitas (Nama Lengkap, Nomor RM, dan Tanggal Lahir).	Minimal 2 indikator identitas cocok sebelum memulai tindakan																		
3.2	**Pengkajian & Target UF**	Menimbang berat badan pre-HD (BB pre), menghitung Interdialytic Weight Gain (IDWG), dan menentukan Target Ultrafiltrasi (UF Goal) berdasarkan Dry Weight.	Target UF = (BB Pre - BB Kering) + estimasi intake cairan intra-HD																		
3.3	**Tanda Vital & Asesmen Klinis Pre**	Mengukur dan mendokumentasikan tanda-tanda vital lengkap pre-HD (Tekanan Darah duduk/berbaring, Nadi, Suhu, Pernapasan, Saturasi O2).	Mendeteksi dini hipertensi urgensi/hipotensi, demam, atau sesak napas (overload)																		
3.4	**Pencegahan Risiko Jatuh (SKP 6)**	Melakukan asesmen risiko jatuh (Skala Morse / Get Up and Go), memasang pita/gelang kuning bila berisiko, dan memastikan pengaman tempat tidur (bed rails) terpasang.	Zero insiden pasien jatuh di unit hemodialisis, bed rail terpasang rapat																		
3.5	**Verifikasi Resep Dialisis (Time Out)**	Melakukan 'Time-Out' verifikasi resep dokter: durasi HD (Time), Quick Blood (QB), Quick Dialysate (QD), UF Goal, dan dosis Heparin (loading & continuous / free heparin).	Cek silang (double check) resep HD bersama perawat partner																		
3.6	**Asesmen & Akses Vaskular Steril**	Memeriksa patensi akses vaskular (bruit & thrill pada AV Fistula/Graft) atau memeriksa kondisi exit site CDL (tanda infeksi/pus/perdarahan) secara aseptik.	Aseptik kanulasi AVF (teknik rope ladder/buttonhole) atau desinfeksi hub CDL steril																		
BAGIAN IV: MONITORING INTRA-HD & PENCEGAHAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)																					
4.1	**Monitoring Hemodinamik & Mesin**	Melakukan observasi tanda vital, keluhan pasien, dan parameter mesin HD (Tekanan Arteri, Tekanan Vena, TMP, volume UF tercapai) setiap 30 - 60 menit.	Dokumentasi di lembar monitoring HD setiap jam secara akurat dan tepat waktu																		
4.2	**Manajemen Tekanan Sirkuit Darah**	Memantau alarm mesin intra-HD (Arterial Pressure, Venous Pressure, Air bubble detector, Blood Leak) dan mengatasi penyebab alarm segera.	Waktu respon alarm < 1 menit, tidak mematikan alarm keamanan mesin																		
4.3	**Pencegahan & Tata Laksana Komplikasi**	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan komplikasi intra-HD (hipotensi intradialitik, kram otot, sakit kepala/mual, disequilibrium, clotting dialyzer).	Intervensi posisi trendelenburg, bolus NaCl 0.9% sesuai advis, penurunan UFR																		
4.4	**Keamanan Jalur & Fiksasi Kanula**	Memastikan fiksasi kanula / jarum fistula dan selang bloodline aman, terlihat jelas (tidak tertutup selimut rapat) untuk mencegah risiko disconnected/perdarahan hebat.	Penerapan standar keselamatan: area insersi jarum tetap terlihat terbuka (visible)																		
BAGIAN V: EDUKASI TERSTRUKTUR KEPADA PASIEN & KELUARGA (DIET, CAIRAN, KEBERSIHAN DIRI)																					
5.1	**Edukasi Pembatasan Cairan**	Memberikan KIE pembatasan asupan cairan harian (jumlah urin 24 jam + 500-750 mL), cara mengukur asupan minum, dan bahaya overload cairan (sesak/bengkak).	Pasien/keluarga mampu menyebutkan batas kuota minum & target kenaikan BB < 5%																		
5.2	**Edukasi Diet & Nutrisi Ginjal**	Memberikan edukasi diet ginjal: konsumsi protein bermutu tinggi (telur/ikan), pembatasan natrium/garam, pembatasan buah/sayur tinggi kalium, dan makanan tinggi fosfat.	Pasien memahami pantangan makanan tinggi kalium (pisang, air kelapa, dll.) & fosfat																		
5.3	**Edukasi Kebersihan Diri & Akses Vaskular**	Mengedukasi personal hygiene: mandi bersih, menjaga luka tusukan tetap kering 24 jam post-HD, tidak menggaruk area fistula, serta menjaga kebersihan CDL.	Eksit site CDL & AV Shunt terbebas dari infeksi dan kontaminasi air saat mandi																		
5.4	**Edukasi Perawatan Fistula / CDL Mandiri**	Mengedukasi larangan pada tangan akses (tidak boleh pasang manset tensi, ambil darah, tertindih tidur, mengangkat beban > 5 kg) dan cara raba getaran thrill harian.	Pasien mampu meraba getaran thrill Cimino sendiri setiap pagi dan malam hari																		
5.5	**Edukasi Obat Pengikat Fosfat & Kepatuhan**	Memberikan edukasi cara minum obat pengikat fosfat (phosphate binder dikunyah bersamaan saat suapan makan) dan kepatuhan jadwal hemodialisis teratur.	Kepatuhan jadwal HD 2x/3x seminggu dan cara konsumsi obat pengikat fosfat tepat																		
BAGIAN VI: TERMINASI AMAN, EVALUASI POST-HD, DISINFEKSI MESIN & PENDOKUMENTASIAN																					
6.1	**Terminasi HD Aman (Washback)**	Mengembalikan darah dari sirkuit ke tubuh pasien (washback/reinfusi) menggunakan NaCl 0.9% secara perlahan dan aman tanpa udara masuk ke vaskular.	Darah kembali bersih sempurna, sirkuit darah dibilas tuntas, udara dicegah total																		
6.2	**Hemostasis & Balut Tekan Akses**	Melakukan penekanan luka bekas kanulasi (hemostasis) secara tepat 10-15 menit hingga perdarahan berhenti, lalu memasang balut tekan tanpa mematikan desiran thrill AVF.	Perdarahan berhenti tuntas, tidak terjadi hematoma/pseudoaneurisma, thrill tetap kuat																		
6.3	**Evaluasi TTV & Berat Badan Post-HD**	Mengukur tanda vital post-HD dan menimbang berat badan post-HD untuk mengevaluasi tercapainya berat badan kering (Dry Weight) dan toleransi hemodinamik.	TTV stabil (tidak ada hipotensi ortostatik), selisih BB mendekati dry weight																		

6.4	**Disinfeksi Mesin HD (Heat / Chemical)**	Melakukan siklus disinfeksi mesin HD (Heat Disinfection / Chemical Citric/Bleach sesuai SOP) segera setelah sirkuit dilepas dari pasien.	Siklus disinfeksi komplit (Done), siap digunakan untuk shift/pasien berikutnya																			
6.5	**Dokumentasi Asuhan & Rekam Medis (CPPT)**	Mendokumentasikan seluruh asuhan keperawatan HD (SOAP/CPPT, lembar monitoring, penggunaan obat/cairan, dan laporan insiden bila ada) secara lengkap dan legal.	Dokumentasi ditandatangani perawat penanggung jawab & dokter jaga dalam 1x24 jam																			
			JUMLAH KEGIATAN TERLAKSANA PER HARI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mengetahui & Menyatakan,

Perawat Pelaksana Hemodialisis

(.....)

NIP/NIRA: .....

Bula Oktober / 2026

Kual PK I / PK II / PK III Dia

Shift [ ] Pagi [ ] Siang

ERJALAN)													TOTAL (V)	% CAPAIAN	KETERANGAN / PARAF
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	
													0	0.0%	

												0	0.0%	
												0	0.0%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	*Rata-rata Kepatuhan*

Diverifikasi & Disetujui oleh,

Kepala Ruangan / Supervisor Hemodialisis

(.....)

NIP: .....